



VALURA
ACADEMY

Sepse: reconhecimento e primeira hora

Da beira-leito à decisão de escalar — abordagem baseada em evidência

Prof. Dr. Igor Moraes · CRM-MG 76695 · RQE 59902 / 59904 / 66254 · Urgência e Emergência · Carga horária: 1h

v6.0 · 2026-07-15

O paciente que atravessa a aula

H., 78 anos, homem, com sequela de AVC e sonda vesical de longa permanência. A enfermagem percebe um novo delirium hipoativo, FR 24 irpm, PAS 98 mmHg, Tax 35,8 °C, urina turva e enchimento capilar de 4 segundos.

Não há febre — e o estado mental já era alterado antes. É exatamente aí que a sepse costuma passar despercebida.

Sem febre e com estado mental alterado de base, como não deixar essa sepse passar?

OBJETIVOS

Ao final desta aula, você será capaz de...

- 1** Reconhecer a sepse precocemente à beira-leito, inclusive no idoso e no neurológico com apresentação atípica.
- 2** Executar o pacote da primeira hora: culturas antes do antibiótico e ressuscitação individualizada.
- 3** Estratificar o tempo do antibiótico pela probabilidade de infecção e pela presença de choque (SSC 2026).
- 4** Decidir quando escalonar ou transferir e integrar cuidados paliativos e proporcionalidade terapêutica.

O caminho de hoje

1

Por que a sepse é emergência tempo-dependente

2

Como reconhecer: definições, rastreamento e a sepse oculta

3

Como agir: pacote da 1ª hora, antibiótico e volume

4

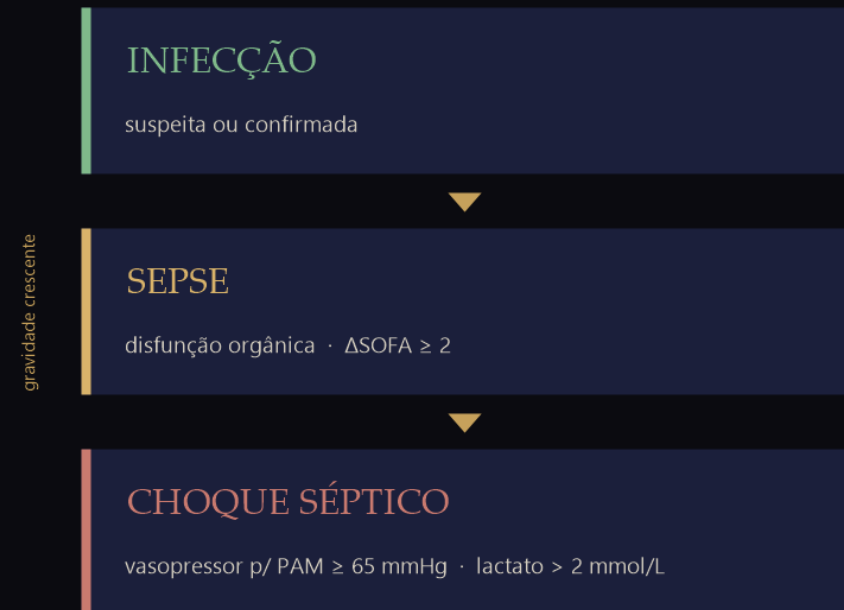
Como decidir: transferência e teto de cuidado

Sepse é uma emergência tempo-dependente

- Mortalidade hospitalar do choque séptico maior que 40%.
- Conclusão mais rápida do pacote e do antibiótico associou-se a menor mortalidade (Seymour, 2017).
- A sepsé tem alta mortalidade em UTIs brasileiras (estudo SPREAD).
- Maior risco: idosos frágeis, acamados e portadores de dispositivos prolongados (traqueostomia, gastrostomia, sonda vesical, cateter).
- Nesse perfil, a apresentação é oligossintomática — o reconhecimento à beira-leito decide o desfecho.

O que é sepse e o que é choque séptico

- Sepsis = infecção + disfunção orgânica aguda ($\Delta\text{SOFA} \geq 2$).
- Choque séptico = vasopressor p/ PAM ≥ 65 mmHg + lactato > 2 mmol/L após ressuscitação adequada.
- Rastreio: NEWS/NEWS2/MEWS ou SIRS — não o qSOFA como ferramenta única (SSC).
- O SOFA confirma a disfunção; não é ferramenta de triagem.



Um continuum de gravidade

Por que a infecção vira disfunção orgânica

- A sepse é uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção: a lesão de órgãos vem da própria resposta, não só do micro-organismo.
- A hipoperfusão tecidual eleva o lactato e se traduz em disfunção de órgãos, medida pelo Δ SOFA.
- No idoso frágil, a reserva fisiológica reduzida faz pequenas variações hemodinâmicas já significarem disfunção relevante.
- Por isso a sepse se esconde: a febre pode faltar e o 1º sinal é neurológico/funcional (delirium, queda funcional).

A sepse que se esconde no idoso e no neurológico

- A febre pode estar ausente; a hipotermia ($< 36^{\circ}\text{C}$) é sinal de gravidade.
- Delirium — sobretudo hipoativo — e queda funcional podem ser o primeiro sinal.
- Compare sempre NEWS2 e SOFA com o basal; documentar o basal na admissão torna o reconhecimento objetivo.
- Focos frequentes: urinário (sonda), pulmonar (broncoaspiração), pele/lesão por pressão e dispositivos.
- Pequenas variações hemodinâmicas podem já representar disfunção significativa.

Rastrear, dosar e colher — na ordem certa

- $\text{NEWS2} \geq 5$ (ou 3 em um único parâmetro) = alto risco → avaliação médica imediata.
- Colha 2 hemoculturas e a cultura do foco ANTES do antibiótico — sem atrasá-lo no choque.
- Dose o lactato; onde não há laboratório imediato, o enchimento capilar é alvo de perfusão simples e barato.
- Culturas por foco: urocultura/EAS, aspirado traqueal, hemocultura do cateter, conforme a suspeita.

O que mascara e o que confunde a sepse

- O desafio é separar a deterioração NOVA da alteração crônica de base — por isso o basal documentado é decisivo.
- Delirium hipoativo é confundido com sonolência, depressão ou piora da doença de base.
- A ausência de febre — ou a hipotermia — desvia o raciocínio de infecção.
- No neurológico com estado mental já alterado, o qSOFA perde sensibilidade: não o use como triagem.

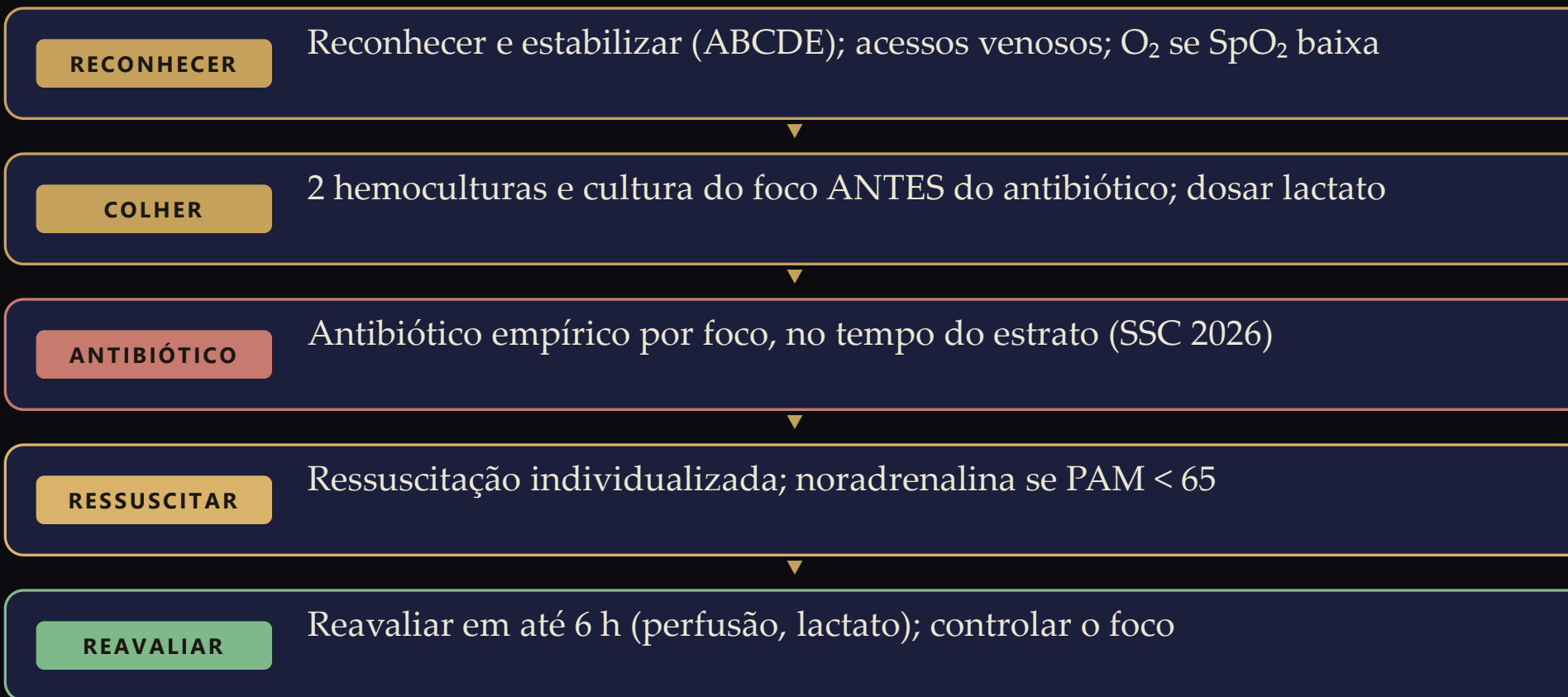
Pare e recupere

? Sobre a ferramenta de RASTREIO de sepse recomendada à beira-leito (SSC), é correto afirmar que:

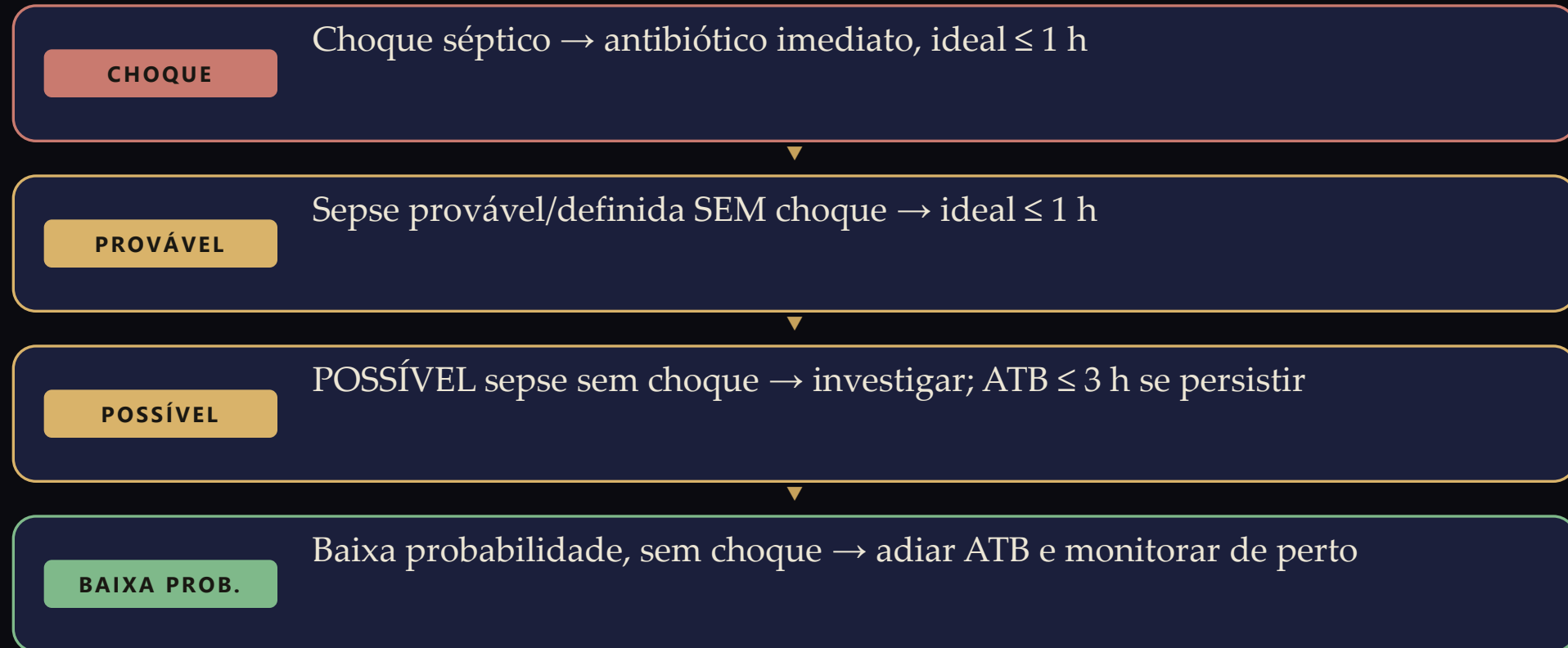
- A) O qSOFA é a ferramenta de rastreio preferida
- B) A SSC recomenda NEWS/NEWS2/MEWS ou SIRS — e NÃO o qSOFA — como ferramenta única de rastreio, por maior sensibilidade
- C) A febre é obrigatória para reconhecer a sepse
- D) SIRS está proibido em qualquer cenário

Resposta: B · A SSC recomenda NEWS/NEWS2/MEWS ou SIRS em vez do qSOFA como rastreio único (maior sensibilidade).

Pacote da primeira hora



Tempo do antibiótico — estratificado (SSC 2026)



Metas de ressuscitação (SSC 2026)

- Cristalóide: PELO MENOS 30 mL/kg em até 3 h (SSC 2026 — condicional, certeza BAIXA) → individualizar e reavaliar.
- Evite a sobrecarga no idoso frágil, no cardiopata e no renal crônico.
- Alvo inicial de PAM de 65 mmHg, em vez de alvos maiores (SSC 2026 — FORTE, certeza moderada); noradrenalina é a 1ª escolha após o volume.
- No idoso de 65 anos ou mais com choque séptico, a SSC 2026 sugere faixa inicial de PAM 60-65 mmHg — condicional, certeza BAIXA.
- Enchimento capilar guia a perfusão onde não há laboratório imediato (ANDROMEDA-SHOCK; adjuvante na SSC 2026).

Os erros que atrasam ou desviam o cuidado

- Esperar a febre: no neurológico, o sinal é a MUDANÇA vs. o basal (delirium novo, recusa, hipotermia).
- Tratar só o antibiótico e esquecer o foco: remover ou trocar o dispositivo importa tanto quanto o ATB.
- Atrasar o antibiótico no choque para colher exame ou imagem.
- Cobrar a meta de 1 hora de todo caso — ela não se aplica à possível sepse sem choque.

Quando escalonar e quando transferir

- Choque séptico ou necessidade de vasopressor sem estrutura segura de infusão = critério de transferência.
- Não atrase o antibiótico enquanto organiza o transporte.
- Acione a regulação, comunique com ISBAR e garanta transporte seguro, registrando os horários.
- Lactato persistentemente elevado, insuficiência respiratória ou disfunção orgânica progressiva também indicam escalonar.
- Quem tem indicação de UTI deve ser admitido em até 6 h — SSC 2026 (condicional, certeza baixa).
- Cuidado: são DOIS prazos de 6 h diferentes — reavaliar a perfusão (pacote da 1ª hora) e admitir em UTI quem tem indicação.

Quando o teto de cuidado muda a meta — não o cuidado

- Discuta metas de cuidado e prognóstico com paciente e família — boa prática (SSC 2026); aborde até 72 h (condicional).
- Princípios de cuidados paliativos integram o plano (boa prática); a SSC 2026 sugere CONTRA o parecer formal de rotina (condicional).
- Fase terminal de doença grave e incurável: permitido limitar o que só prolonga a vida, respeitada a vontade da pessoa (CFM 1.805/2006).
- Limitar não é abandonar: seguem todos os cuidados que aliviam o sofrimento (art. 2º).
- A decisão é fundamentada e registrada no prontuário (art. 1º, § 2º).
- Com teto de cuidado paliativo, a meta vira conforto (dispneia, dor, secreções, delirium); o antibiótico entra se aliviar o sofrimento.

Onde a evidência ainda discute

- qSOFA saiu do rastreio: a baixa sensibilidade fez a SSC recomendar contra usá-lo como ferramenta única.
- Tempo do antibiótico: a SSC 2026 estratifica — não se deve cobrar '1 hora' na possível sepse sem choque.
- Volume: os 30 mL/kg fixos têm baixa certeza de evidência; o alvo ótimo é individual.
- Enchimento capilar × lactato: no ANDROMEDA-SHOCK o alvo perfusional não reduziu mortalidade em 28 d, mas validou meta simples e barata.

Caso: choque numa unidade sem CTI

? Numa unidade sem CTI no local, qual achado é critério para acionar transferência ou escalonamento?

- A) Melhora clínica com lactato em queda
- B) Choque séptico/hipotensão refratária ao volume ou necessidade de vasopressor sem estrutura segura de infusão
- C) NEWS2 = 1
- D) Foco urinário já controlado com retirada da sonda

Resposta: B · Choque ou necessidade de vasopressor sem estrutura segura de infusão e monitorização é critério de transferência.

O que sobrevive a esta aula

- 1 Suspeita de infecção + mudança vs. basal → pense em sepse; rastreie por NEWS2 (qSOFA fora da triagem).
- 2 Culturas antes do antibiótico, mas o antibiótico tem prioridade no choque.
- 3 O tempo do antibiótico é estratificado (SSC 2026): ≤ 1 h no choque; ≤ 3 h na possível sepse sem choque.
- 4 Volume individualizado; alvo inicial de PAM 65 mmHg — não alvos maiores; enchimento capilar e lactato guiam a perfusão.
- 5 Sem CTI, reconheça cedo os critérios de transferência e integre o teto de cuidado.

Você revisa isto em...

D+7

Recuperação: definições, rastreio e o pacote da 1ª hora

D+30

Consolidação: tempo do antibiótico e ressuscitação

D+90

Retenção: caso novo, decisão de transferir e teto de cuidado

REFERÊNCIAS

Referências (Vancouver)

- 1 Prescott HC, Antonelli M, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2026. Crit Care Med. 2026;54(4):725-812. doi:10.1097/CCM.0000000000007075.
- 2 Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign 2021. Crit Care Med. 2021;49(11):e1063-e1143.
- 3 Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801-810.
- 4 Seymour CW, Gesten F, Prescott HC, et al. Time to treatment and mortality during mandated emergency care for sepsis. N Engl J Med. 2017;376(23):2235-2244.
- 5 Hernández G, Ospina-Tascón GA, Damiani LP, et al. ANDROMEDA-SHOCK. JAMA. 2019;321(7):654-664.
- 6 Levy MM, Evans LE, Rhodes A. The Surviving Sepsis Campaign Bundle: 2018 update. Intensive Care Med. 2018;44(6):925-928.
- 7 Machado FR, et al. Epidemiology of sepsis in Brazilian ICUs (SPREAD). Lancet Infect Dis. 2017;17(11):1180-1189.
- 8 Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2. London: RCP; 2017.
- 9 Instituto Latino-Americano de Sepse (ILAS). Protocolos e pacotes de sepse. Disponível em: <https://ilas.org.br>.
- 10 ANVISA. Critérios diagnósticos de IRAS (Caderno 2). Brasília: ANVISA.
- 11 Conselho Federal de Medicina (BR). Resolução CFM nº 1.805/2006 (ortotanásia). DOU 28 nov 2006;Seção 1:169. — Resolução CFM nº 2.156/2016 (admissão e alta em UTI). DOU 17 nov 2016;Seção 1:138-9.

Créditos de imagem

continuum-sepse.png

esquema próprio · Valura Academy · obra própria — uso comercial autorizado · acervo próprio (não publicado)

marca-ouro.png

favicon.svg (rasterizado) · Valura · marca própria · <https://valura.health>

halo-indigo.png

gradiente radial gerado (fundo da capa) · Valura · obra própria — uso comercial autorizado · acervo próprio (assets/Build-Assets.ps1)